

Chapitre 5. DÉFORMATIONS DE LA CAGE THORACIQUE : PECTUS EXCAVATUM, PECTUS CARINATUM

1. Quelle est la déformation la plus fréquente de la paroi thoracique ?

- A. Pectus Carinatum
- B. Pectus Excavatum
- C. Scoliose
- D. Thorax en carène

B

2. Quel est le ratio garçon/fille pour l'incidence du Pectus Excavatum ?

- A. 1:1
- B. 2:1
- C. 3:1
- D. 4:1

C

3. Quelle est la cause principale du Pectus Excavatum ?

- A. Infections répétées
- B. Anomalie de croissance du cartilage costal
- C. Traumatisme thoracique
- D. Carence en vitamine D

B

4. Quel est le symptôme le plus courant du Pectus Excavatum chez les jeunes enfants ?

- A. Douleur au sternum
- B. Diminution progressive de la tolérance à l'effort
- C. Palpitations
- D. Augmentation de la fréquence cardiaque

B

5. Quel pourcentage des patients atteints du syndrome de Marfan présente un thorax en entonnoir ?

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 30%

D

6. Quel examen est de choix pour évaluer la gravité du Pectus Excavatum ?

- A. Radiographie thoracique
- B. Échocardiogramme
- C. Scanner thoracique
- D. Spirométrie

C

7. Quelle valeur de l'index de Haller est considérée comme pathologique ?

- A. Entre 1,75 et 2,6
- B. Entre 2,6 et 3,1

- C. Supérieure à 3,1
- D. Inférieure à 1,75

C

8. Quelle technique chirurgicale est le "gold standard" pour traiter le Pectus Excavatum ?

- A. Chirurgie ouverte du sternum
- B. Sternocondroplastie mini-invasive de Nuss
- C. Correction du thorax par corset
- D. Chirurgie du cartilage costal

B

9. Quelle est la principale cause du Pectus Carinatum ?

- A. Anomalie de la croissance du cartilage costal
- B. Traumatisme thoracique
- C. Malformation cardiaque
- D. Infection respiratoire

A

10. Quel traitement est principalement utilisé pour le Pectus Carinatum ?

- A. Chirurgie immédiate
- B. Physiothérapie et port de corsets correcteurs
- C. Médicaments anti-inflammatoires
- D. Traitement antibiotique

B

Chapitre 6. HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGÉNITALE

1. Quelle est la malformation impliquée dans la hernie diaphragmatique congénitale ?

- A. Déformation du sternum
- B. Insuffisance du diaphragme
- C. Malformation du cœur
- D. Fente palatine

B

2. Quelle est l'incidence estimée de la hernie diaphragmatique congénitale ?

- A. 1/1000
- B. 1/5000
- C. 1/10 000
- D. 1/50 000

B

3. Quel est le nom du foramen par lequel la majorité des hernies diaphragmatique congénitales se produisent ?

- A. Foramen de Morgagni
- B. Foramen de Bochdalek
- C. Fente de Larrey
- D. Foramen de Ladd

B

4. Quel organe est souvent hypoplasique dans le cas de la hernie diaphragmatique congénitale ?

- A. Foie
- B. Cœur
- C. Poumon gauche
- D. Estomac

C

5. Quel est le principal effet physiopathologique de la hernie diaphragmatique congénitale sur les poumons ?

- A. Hypertension pulmonaire
- B. Augmentation de la capacité pulmonaire
- C. Hypoplasie pulmonaire
- D. Pneumothorax

C

6. À partir de quelle semaine de grossesse peut-on diagnostiquer la hernie diaphragmatique congénitale par échographie ou IRM ?

- A. 10^e semaine
- B. 20^e semaine
- C. 30^e semaine
- D. 40^e semaine

B

7. Quel est l'indicateur de survie le plus associé au pronostic dans les cas de hernie diaphragmatique congénitale ?

- A. La position du foie
- B. Le rapport poumon/crâne (LHR)
- C. La présence d'une malformation cardiaque
- D. La taille du thorax

B

8. Quel traitement peut être effectué in-utéro pour améliorer les chances de survie du fœtus avec une hernie diaphragmatique congénitale ?

- A. Chirurgie ouverte
- B. Occlusion endoscopique trachéale par ballonnet (FETO)
- C. Réduction du volume pulmonaire
- D. Administration de surfactant

B

9. Quelle approche chirurgicale est utilisée pour traiter la hernie diaphragmatique congénitale ?

- A. Laparotomie médiane uniquement
- B. Thoracotomie gauche uniquement
- C. Laparotomie ou thoracotomie selon la localisation de la hernie
- D. Chirurgie par voie endoscopique uniquement

C

10. Quelle est la mortalité estimée des patients atteints de hernie diaphragmatique congénitale ?

- A. 5-10 %
- B. 10-15 %
- C. 15-20 %

D. 20-30 %

C

Chapitre 7. ATRÉSIE DE L'ŒSOPHAGE

1. Quelle(s) caractéristique(s) sont associées à l'atresie de l'œsophage ?

- A. Hypersalivation
- B. Difficulté à déglutir
- C. Cyanose
- D. Vomissements fréquents
- E. Insuffisance rénale

ABC

2. Quel(s) sont les types d'atresie de l'œsophage selon la classification de Ladd et Roberts ?

- A. Type I
- B. Type II
- C. Type IIIa
- D. Type IV
- E. Type V

ABCDE

3. Quelle(s) malformation(s) peut-on retrouver en association avec l'atresie de l'œsophage ?

- A. Malformations cardiaques
- B. Malformations pulmonaires
- C. Malformations rénales
- D. Malformations du tube neural
- E. Syndromes génétiques (ex : syndrome de Down, syndrome CHARGE)

ACE

4. Quels sont les signes cliniques fréquents chez un nouveau-né avec atresie de l'œsophage ?

- A. Hypersalivation
- B. Incapacité de déglutir
- C. Brûlures d'estomac
- D. Détresse respiratoire
- E. Ballonnement abdominal

ABD

5. Quelles techniques sont utilisées pour allonger les moignons œsophagiens dans le cas d'une atresie de l'œsophage à grand écart (LGEA) ?

- A. Traction progressive avec des fils de suture
- B. Utilisation d'un patch de Gore-Tex
- C. Utilisation d'aimants pour traction
- D. Anesthésie locale pour étirer les moignons
- E. Greffe de tissu pulmonaire

AC

6. Quelle est la technique chirurgicale de choix pour la réparation de l'atresie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne ?

- A. Thoracotomie droite
- B. Thoracoscopie
- C. Laparotomie médiane
- D. Gastrostomie cervicale
- E. Anesthésie générale avec intubation oro-trachéale

ABE

7. Quelle(s) complication(s) peuvent survenir après la chirurgie de l'atresie de l'œsophage ?

- A. Infection
- B. Récidive de la fistule trachéo-œsophagienne
- C. Sténose de l'anastomose
- D. Désunion de l'anastomose
- E. Insuffisance respiratoire aiguë

ABCD

8. Quelle(s) complication(s) respiratoire(s) sont associées à l'atresie de l'œsophage ?

- A. Pneumonie d'aspiration
- B. Malformations cardiaques
- C. Hypertension pulmonaire
- D. Distension abdominale avec ascension du diaphragme
- E. Trachéomalacie

ACE

9. Quelle(s) méthode(s) permettent de confirmer le diagnostic d'atresie de l'œsophage après la naissance ?

- A. Radiographie thoraco-abdominale
- B. Échographie
- C. Fibroscopie œsophagienne
- D. Sonde naso-gastrique radio-opaque
- E. Tomodensitométrie

AD

10. Quelle(s) approche(s) chirurgicale(s) peuvent être utilisées pour réparer l'atresie de l'œsophage ?

- A. Thoracotomie extrapleurale droite
- B. Laparotomie médiane
- C. Gastrostomie et œsophagostomie cervicale
- D. Réparation par patch de Gore-Tex
- E. Anastomose termino-terminale

ACE

Chapitre 8. STENOSE HYPERTROPHIQUE DU PYLORE

1. Quelle est la principale caractéristique anatomopathologique de la sténose hypertrophique du pylore ?

- A. Hypotrophie des couches musculaires du pylore
- B. Hypertrophie des couches musculaires circulaires et longitudinales du pylore
- C. Augmentation de la taille de l'estomac
- D. Augmentation de la taille du duodénum
- E. Sténose du cardia

B

2. Quel est le facteur génétique associé à la sténose hypertrophique du pylore ?

- A. La présence d'un antécédent familial positif
- B. La prédisposition génétique chez les Africains
- C. La prédisposition génétique chez les Caucasiens
- D. Les facteurs hormonaux
- E. Aucun facteur génétique n'est impliqué

AC

3. Quels sont les signes cliniques caractéristiques de la sténose hypertrophique du pylore ?

- A. Vomissements en jet, non bilieux
- B. Vomissements bilieux
- C. Ondes péristaltiques visibles dans l'épigastre
- D. Palpation d'une olive pylorique
- E. Déshydratation sévère dès la naissance

ACD

4. Quelle méthode est considérée comme le "gold standard" pour le diagnostic de la sténose hypertrophique du pylore ?

- A. Radiographie avec baryum
- B. Échographie abdominale
- C. Endoscopie
- D. Examen clinique uniquement
- E. Tomodensitométrie (scanner)

B

5. Quelle est la cause la plus fréquente de vomissements non bilieux chez les nouveau-nés ?

- A. Sténose hypertrophique du pylore
- B. Reflux gastro-œsophagien
- C. Gastro-entérite virale
- D. Pylorospasme
- E. Intolérance au lactose

A

6. Quels facteurs environnementaux ont été décrits comme des facteurs prédisposants à la sténose hypertrophique du pylore ?

- A. Exposition à l'erythromycine
- B. Alimentation artificielle
- C. Exposition à des pesticides
- D. Infection virale en période néonatale
- E. Sélection alimentaire des nourrissons

ABC

7. Quelle complication est associée à la piloromyotomie ?

- A. Infection du site opératoire
- B. Perforation de la muqueuse duodénale
- C. Hypotension post-opératoire
- D. Hyperthermie
- E. Diarrhée persistante

AB

8. Quelle est la principale méthode de traitement chirurgical de la sténose hypertrophique du pylore ?

- A. Pyloroplastie
- B. Pyloromyotomie extramuqueuse de Fredet
- C. Gastrectomie partielle
- D. Suture du pylore
- E. Réduction laparoscopique

B

9. Quelle est la prévalence estimée de la sténose hypertrophique du pylore chez les nouveau-nés ?

- A. 1,5 à 4 pour 1000
- B. 10 pour 1000
- C. 0,5 pour 1000
- D. 5 à 7 pour 1000
- E. 0,1 pour 1000

A

10. Quel est l'objectif principal du traitement préopératoire pour la sténose hypertrophique du pylore ?

- A. Chirurgie immédiate
- B. Rééquilibrage hydroélectrolytique et acido-basique
- C. Introduction de l'alimentation dès que possible
- D. Administration d'antibiotiques
- E. Observation sans traitement spécifique

B

Chapitre 9. ATRÉSIE ET STÉNOSE DU DUODÉNUM

1. Quelles sont les causes possibles de l'atrésie du duodénum ?

- A. Défaut de recanalisation de la muqueuse de l'intestin grêle
- B. Malformations cardiaques congénitales
- C. Pancréas en anneau
- D. Sténose du duodénum
- E. Malrotation intestinale

ACE

2. Quelle est la classification anatomopathologique de l'atrésie du duodénum ?

- A. Atrésie de type I
- B. Atrésie de type II
- C. Atrésie de type III
- D. Atrésie complète et incomplète
- E. Atrésie précoce et tardive

ABC

3. Quels sont les symptômes cliniques typiques de l'atrésie du duodénum chez un nouveau-né ?

- A. Vomissements bilieux dès la première heure après la naissance
- B. Abode en forme de scaphoïde
- C. Vomissements non bilieux
- D. Absence de selles méconiales

- E. Vomissements intermittents et alimentaires difficiles

ABD

4. Quelle malformation est souvent associée à l'atrésie du duodénum ?

- A. Syndrome de Down
- B. Malformations cardiaques congénitales
- C. Pancréas en anneau
- D. Volvulus intestinal
- E. Sténose du duodénum

ABC

5. Quelles sont les complications possibles après une correction chirurgicale de l'atrésie du duodénum ?

- A. Fistules anastomotiques
- B. Infection du site opératoire
- C. Volvulus intestinal
- D. Maladie de reflux gastro-œsophagien
- E. Mégaduodénum

ABDE

6. Quels sont les signes radiologiques utilisés pour diagnostiquer l'atrésie du duodénum ?

- A. Signe de l'aile de chauve-souris
- B. Signe de la "double bubble"
- C. Signe de l'intestin enroulé
- D. Présence de gaz dans l'intestin distal
- E. Transit baryté normal

BD

7. Quelle est la principale cause de la sténose du duodénum ?

- A. Compression par le ligament de Ladd
- B. Diaphragme intramural
- C. Malformation cardiaque
- D. Duplication du duodénum
- E. Pancréas en anneau

ABD

8. Quels traitements sont utilisés pour corriger l'atrésie du duodénum ?

- A. Duodénoduodénostomie
- B. Chirurgie laparoscopique
- C. Ponction de l'abdomen
- D. Rééquilibrage hydro-électrolytique
- E. Antagonistes de la gastrine

ABD

9. Quels signes peuvent suggérer une obstruction du duodénum chez un nouveau-né ?

- A. Vomissements bilieux
- B. Selles méconiales en quantité normale
- C. Signe du "double bubble" à la radiographie
- D. Absence de gaz intestinaux distaux
- E. Anomalie à l'échographie cardiaque

ACD

10. Quelle est la mortalité précoce postopératoire pour les nouveau-nés ayant subi une chirurgie pour l'atrésie du duodénum ?

- A. 1-2%
- B. 3-5%
- C. 10-15%
- D. 20-25%
- E. 30-40%

B

Chapitre 10. ATRÉSIE ET STÉNOSE INTESTINALE

1. Quelle est la principale cause de l'obstruction intestinale chez les nouveau-nés ?

- A. Sténose intestinale
- B. Atrésie intestinale
- C. Malrotation intestinale
- D. Hernie interne
- E. Duplication intestinale

AB

2. Quelle est la définition d'une sténose intestinale ?

- A. Une obstruction intestinale causée par un film de muqueuse
- B. Un rétrécissement localisé de la lumière intestinale sans rupture de la paroi
- C. Une perforation du tube digestif
- D. Une malformation du mésentère
- E. Une absence de transit intestinal

B

3. Quel type d'atrésie intestinale implique un cordon fibreux dans le mésentère intact ?

- A. Type I
- B. Type II
- C. Type IIIa
- D. Type IIIb
- E. Type IV

B

4. Quelles sont les caractéristiques de l'atrésie de type IIIa ?

- A. L'anse intestinale proximale se termine de manière aveugle
- B. Il y a continuité entre l'intestin proximal et distal
- C. Le mésentère présente un défaut en « V »
- D. La longueur intestinale est normale
- E. Le mésentère est intact

AC

5. Quelle est la prévalence approximative des malformations intestinales congénitales ?

- A. 1 sur 500 naissances
- B. 1 sur 3000 naissances
- C. 1 sur 5000 naissances
- D. 1 sur 10000 naissances

E. 1 sur 500 naissances

C

6. Quelle est la principale étiologie de l'atrésie jéjunale-iléale selon la théorie généralement acceptée ?

- A. Une malformation génétique
- B. Une lésion ischémique intra-utérine au niveau du méésentère
- C. Un défaut de développement du méésentère
- D. Une infection intra-utérine
- E. Une malrotation intestinale

B

7. Quels symptômes sont caractéristiques de l'atrésie intestinale chez un nouveau-né ?

- A. Vomissements bilieux dès la naissance
- B. Distension abdominale importante dans les obstructions basses
- C. Absence de vomissements
- D. Absence de transit méconial
- E. Diarrhée abondante

ABD

8. Quel examen est le plus utile pour diagnostiquer les malformations intestinales congénitales ?

- A. Échographie fœtale
- B. IRM
- C. Radiographie abdominale
- D. Électromyogramme
- E. Bilan sanguin

AC

9. Quelle est la principale complication post-opératoire après une chirurgie pour atrésie intestinale ?

- A. Infection (péritonite, pneumonie, sepsis)
- B. Malabsorption des graisses
- C. Ulcères anastomotiques tardifs
- D. Obstruction ou fistules anastomotiques
- E. Insuffisance rénale aiguë

ACD

10. Quelle est la conséquence la plus fréquente d'une résection iléale distale chez un nourrisson ?

- A. Problèmes cardiaques
- B. Malabsorption (graisses, vitamine B12, calcium)
- C. Anémie ferriprive
- D. Hypertension artérielle
- E. Diabète

B

Chapitre 11. MALROTATION INTESTINALE ET VOLVULUS INTESTINAL

1. Quelle est la principale caractéristique de la malrotation intestinale ?

- A. Perturbation du processus de rotation et de fixation de l'intestin fœtal
- B. Perturbation de la circulation sanguine intestinale
- C. Torsion du colon ascendant

- D. Évolution toujours symétrique de l'intestin
- E. Douleur abdominale aiguë dès la naissance

A

2. Quelle est la principale cause supposée du volvulus dans la malrotation intestinale ?

- A. Peristaltisme exagéré
- B. Distension brutale de l'intestin grêle
- C. Infection bactérienne de l'intestin
- D. Problèmes de vascularisation
- E. Malformation congénitale du cæcum

AB

3. Dans quel cas le ligament de Ladd apparaît ?

- A. Malrotation complète
- B. Malrotation incomplète
- C. Volvulus sur mésentère commun
- D. Sténose du duodénum
- E. Obstruction du côlon

B

4. Quel type de malrotation intestinale est caractérisé par l'absence de rotation ?

- A. Intestin grêle situé dans l'hémiabdomen droit, côlon dans l'hémiabdomen gauche
- B. Rotation complète de 180°
- C. Rotation inversée de 90°
- D. Présence de ligaments non fixés
- E. Rotation à 270° avec fixation du mésentère

A

5. Quelle est la complication la plus fréquente de la malrotation intestinale ?

- A. Volvulus
- B. Obstruction du duodénum par le ligament de Ladd
- C. Appendicite aiguë
- D. Hernie abdominale
- E. Perforation intestinale

A

6. Quels symptômes sont typiques du volvulus intestinal dans la période néonatale ?

- A. Vomissements bilieux
- B. Distension abdominale rapide
- C. Douleurs abdominales intermittentes
- D. Présence de selles molles
- E. Pleurs déchirants

ABE

7. Lors de la chirurgie pour volvulus, que doit-on faire si les anses intestinales sont viables ?

- A. Réaliser une anastomose
- B. Réaliser une colostomie
- C. Repositionner les anses dans la cavité péritonéale
- D. Effectuer une résection de l'intestin affecté
- E. Fixer les anses à la paroi abdominale

AC

8. Quelle procédure est effectuée pour prévenir la ré-volvulation ou lors de la découverte accidentelle de la malrotation ?

- A. Résection de l'intestin affecté
- B. Chirurgie d'urgence pour arrêter la distension
- C. Procédure de Ladd
- D. Fixation des anses intestinales à la paroi abdominale
- E. Appendicectomie

CE

9. Quel est le rôle de la radiographie abdominale avec substance de contraste ?

- A. Détecter la distension de l'estomac
- B. Identifier la position des anses intestinales
- C. Détecter la présence d'air dans le côlon
- D. Montrer la présence de gaz dans l'hémiabdomen droit
- E. Évaluer les anomalies du duodénum

ABD

10. Quel est le facteur pronostique principal pour le volvulus intestinal ?

- A. La précocité du diagnostic
- B. La qualité de la chirurgie
- C. L'absence de complications postopératoires
- D. La localisation de l'anomalie
- E. La réversibilité de la malrotation

AB

Chapitre 12. MÉGACOLON CONGÉNITAL - MALADIE DE HIRSCHSPRUNG (HD)

1. Quelle est la caractéristique principale du mégacolon congénital ou de la maladie de Hirschsprung ?

- A. Une obstruction mécanique complète du côlon
- B. Une absence de cellules ganglionnaires dans les plexus nerveux du côlon
- C. Une maladie infectieuse du côlon
- D. Une malformation acquise de l'intestin
- E. Une obstructions partielle ou totale du côlon causée par une anomalie congénitale

BE

2. Quel est l'élément central de la physiopathologie de la maladie de Hirschsprung ?

- A. L'absence de propagation de l'onde péristaltique dans le segment aganglionique
- B. L'infection bactérienne généralisée du côlon
- C. Une augmentation de la pression intra-abdominale
- D. La production excessive de toxines par les bactéries
- E. La présence de fibres nerveuses amyéliniques dans le segment aganglionique

ADE

3. Quelle est la cause de l'obstruction fonctionnelle dans la maladie de Hirschsprung ?

- A. La perte de la capacité de contraction du muscle lisse du côlon
- B. L'absence de cellules ganglionnaires dans le plexus nerveux d'Auerbach
- C. Une augmentation de l'acidité gastrique

- D. Une inflammation des parois intestinales
- E. L'absence de motilité dans le segment aganglionique

BE

4. Quelle est la principale investigation paraclinique pour diagnostiquer le mégacolon congénital ?

- A. Tomodensitométrie (scanner abdominal)
- B. Biopsie du côlon
- C. Irrigoclysmie
- D. Échographie abdominale
- E. Manométrie anorectale

BC

5. Quelle est l'anatomie typique d'un segment de côlon aganglionique dans la maladie de Hirschprung ?

- A. Un segment de côlon normal sans anomalies visibles
- B. Un segment de côlon qui est totalement absent de cellules ganglionnaires
- C. Un côlon normal au-dessus de la zone aganglionique
- D. Un côlon qui se dilate et se décalibre progressivement au niveau de la zone de transition
- E. Un segment aganglionique avec une dilatation modérée uniquement

BCD

6. Quels symptômes peuvent apparaître chez un nouveau-né atteint de mégacolon congénital ?

- A. Vomissements bilieux et fécaloïdes
- B. Distension abdominale progressive
- C. Éruption cutanée généralisée
- D. Absence d'élimination du méconium dans les 24-48 heures
- E. Douleurs abdominales aiguës

ABD

7. Quelle procédure chirurgicale est souvent utilisée pour traiter la maladie de Hirschprung ?

- A. Abdominoplastie
- B. Anastomose du côlon fonctionnel à l'anus
- C. Colostomie temporaire
- D. Excision de la muqueuse rectale et anastomose via manchon musculaire rectal
- E. Résection partielle du rectum

BCD

8. Quelle est la durée minimale recommandée avant de procéder à la chirurgie définitive du mégacolon congénital ?

- A. 1 à 2 semaines
- B. 4 à 6 semaines
- C. 8 à 12 semaines
- D. 6 à 12 mois
- E. 2 ans

C

9. Quelle méthode permet d'étudier l'altération fonctionnelle de la défécation dans le diagnostic de Hirschprung ?

- A. Biopsie rectale
- B. Irrigoclysmie

- C. Manométrie anorectale
- D. Échographie du rectum
- E. Scanner abdominal

C

10. Quelle condition doit être exclue dans le diagnostic différentiel du mégacolon congénital ?

- A. Malformations anorectales
- B. Ileus méconial
- C. Hypothyroïdie
- D. Atresie du côlon
- E. Syndrome de colon irritable

ABD

Chapitre 13-18

1. Concernant la maladie de Hirschsprung, quel est l'examen de choix pour le diagnostic ?

- A. Une radiographie pulmonaire
- B. Une irigoclyse
- C. Une échographie abdominale
- D. Une IRM cérébrale

B

2. Quelle est l'incidence des malformations anorectales ?

- A. 1:1000-1:2000
- B. 1:3500-1:5000
- C. 1:7000-1:9000
- D. 1:10 000-1:15 000

B

3. Quelle est la cause principale du laparoschisis ?

- A. Une anomalie génétique du chromosome 21
- B. Un traumatisme lors de l'accouchement
- C. Un événement thrombotique dans la veine ombilicale droite
- D. Une carence en acide folique

C

4. Quelle est la différence principale entre un laparoschisis et une omphalocèle ?

- A. L'omphalocèle est toujours associée à une atresie intestinale
- B. Dans le laparoschisis, les viscères sont recouverts d'une membrane protectrice
- C. L'omphalocèle est recouverte d'une membrane translucide alors que dans le laparoschisis, les viscères sont à découvert
- D. Le laparoschisis touche uniquement les prématurés

C

5. Quelle est la technique chirurgicale utilisée pour traiter un mégacolon congénital ?

- A. Technique de Nissen
- B. Technique de Swenson, Soave ou Duhamel
- C. Appendicectomie simple
- D. Hémicolectomie droite

B

6. Quel est le traitement principal d'une hernie inguinale chez l'enfant ?

- A. Une cure par laparotomie associée à une colostomie
- B. Une réparation par pose de prothèse en polypropylène
- C. Une chirurgie de ligature du canal péritonéo-vaginal
- D. Une prise en charge conservatrice avec surveillance

C

7. Quelle est la complication redoutée d'une chirurgie du laparoschisis ?

- A. Une occlusion intestinale haute
- B. Un syndrome du compartiment abdominal
- C. Une perforation œsophagienne
- D. Une septicémie due à une infection urinaire

B

8. Quelle est la principale anomalie associée à la cryptorchidie ?

- A. Hypospadias
- B. Atrésie duodénale
- C. Hémangiome hépatique
- D. Spina bifida

A

9. À quel âge recommande-t-on une intervention pour une hernie ombilicale persistante ?

- A. Dès la naissance
- B. À 6 mois
- C. À 2 ans si le diamètre est supérieur à 1,5 cm
- D. À 18 ans
- E. 4 ans

E

10. Quelles sont les trois couches qui composent la membrane de l'omphalocèle ?

- A. Péritoine pariétal, gelée de Wharton, membrane amniotique
- B. Muqueuse intestinale, mésentère, fascia de Gerota
- C. Séreuse, musculaire, sous-muqueuse
- D. Épithélium, tissu adipeux, fascia de Camper

A

Chapitre 18. CRYPTORCHIDIE

1. Quelle est la définition de la cryptorchidie ?

- A. Retard de la descente des testicules
- B. Testicule situé en dehors du scrotum
- C. Testicule malformé
- D. Testicule absent
- E. Testicule dans la cavité abdominale

AE

2. Parmi les situations suivantes, laquelle ne correspond pas à un type de cryptorchidie ?

- A. Ectopie testiculaire

- B. Testicule flottant
- C. Testicule rétractile
- D. Testicule intra-abdominal
- E. Testicule bilatéral

E

3. Quel est le pourcentage d'incidence de la cryptorchidie chez les prématurés ?

- A. 3%
- B. 33–45%
- C. 1%
- D. 10%
- E. 50%

B

4. Quelles sont les étapes nécessaires à la descente des testicules ?

- A. Processus hormonal uniquement
- B. Interaction entre les systèmes endocrinien, paracrin et mécanique
- C. Dépendance de l'intégrité de l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire
- D. Migration des testicules uniquement par les vaisseaux sanguins
- E. Migration des testicules dans la cavité abdominale

BC

5. Quelles anomalies peuvent être associées à la cryptorchidie ?

- A. Hypospadias
- B. Enurésie
- C. Malformations génito-urinaires
- D. Torsion testiculaire
- E. Malignité

ABC

6. Quelle est la principale modalité thérapeutique dans la cryptorchidie ?

- A. Traitement médical avec des hormones
- B. Chirurgie de descente testiculaire
- C. Surveillance annuelle sans intervention
- D. Approche psychologique pour l'enfant
- E. Traitement de la douleur

B

7. À quel âge la descente du testicule est-elle la plus probable ?

- A. 1 an
- B. 6-12 mois
- C. 18 mois
- D. 5 ans
- E. 12 ans

B

8. Quelle technique d'exploration paraclinique est la plus fidèle pour le diagnostic de cryptorchidie ?

- A. Échographie
- B. IRM

- C. Laparoscopie exploratoire
- D. Test de grossesse
- E. Cystoscopie

C

9. Quelle complication est fréquemment associée à un testicule cryptorchide ?

- A. Stérilité
- B. Infertilité temporaire
- C. Augmentation du risque de malignité
- D. Rétraction testiculaire
- E. Risque d'ectopie

AC

10. Quel est le pronostic chez les patients avec un testicule intra-abdominal ?

- A. Pronostic favorable avec traitement rapide
- B. Pronostic réservé si la descente est tardive
- C. La stérilité est quasi impossible
- D. La malignité est rare
- E. La descente peut survenir spontanément à l'adolescence

BE

Chapitre 19. SCROTUM AIGU

1. Quelle est la principale caractéristique clinique de la torsion testiculaire ?

- A. Douleur violente localisée dans le scrotum
- B. Douleur irradiant vers la région lombaire
- C. Tuméfaction scrotale indolore
- D. Testicule ascensionné vers la partie supérieure du scrotum
- E. Présence d'une éruption cutanée sur le scrotum

AD

2. Quelle est la première mesure à prendre en cas de suspicion de torsion testiculaire ?

- A. Prendre un antalgique pour soulager la douleur
- B. Effectuer une échographie scrotale
- C. Tenter une détorsion manuelle si possible
- D. Prescrire des antibiotiques
- E. Réaliser une exploration chirurgicale immédiate

CD

3. Quelles sont les complications possibles après une intervention chirurgicale pour torsion testiculaire ?

- A. Hématome scrotal
- B. Infection de la plaie opératoire
- C. Granulome du fil
- D. Insuffisance rénale
- E. Perte de fonction érectile

ABC

4. Quelle est la principale différence clinique entre la torsion testiculaire et la torsion de l'hydride de Morgagni ?

- A. La torsion de l'hydatide de Morgagni provoque un œdème sévère du testicule
- B. La torsion de l'hydatide de Morgagni est souvent associée à un "blue dot" à la transillumination
- C. La torsion testiculaire est généralement plus douloureuse que la torsion de l'hydatide de Morgagni
- D. La torsion testiculaire présente un testicule de volume normal
- E. La torsion de l'hydatide de Morgagni ne provoque aucune douleur

BC

5. Quelle méthode peut être utilisée pour différencier la torsion testiculaire de l'orchite ou de l'épididymite ?

- A. Réaliser un examen clinique complet
- B. Pratiquer une échographie scrotale avec Doppler
- C. Effectuer un examen physique uniquement
- D. Utiliser un examen de la fonction rénale
- E. Effectuer une culture de l'urine

AB

6. Quelle est la gestion de la torsion de l'hydatide de Morgagni lorsqu'elle est diagnostiquée ?

- A. Chirurgie immédiate de l'hydatide
- B. Surveillance et traitement conservateur dans la majorité des cas
- C. Réalisation d'une orchiectomie
- D. Traitement antibiotique
- E. Exploration scrotale pour ligature et excision si nécessaire

BE

7. Quelle est l'incidence des traumatismes scrotaux et testiculaires dans la population ?

- A. Plus fréquents chez les adultes
- B. Rare, inférieure à 1 %
- C. Plus fréquents chez les adolescents
- D. Fréquents après 50 ans
- E. Surviennent souvent après des sports de contact

BC

8. Quelle est la principale cause des traumatismes scrotaux chez les jeunes enfants ?

- A. Accidents de sport
- B. Chutes
- C. Accidents de vélo
- D. Accidents de jeu
- E. Traumatisme lors de la baignade

BD

9. Dans quelle situation la détorsion manuelle est-elle la plus bénéfique ?

- A. Si le patient consulte plus de 24 heures après le début des symptômes
- B. Si la torsion testiculaire est accompagnée d'œdème scrotal
- C. Si le patient consulte dans les 6 heures suivant l'apparition des symptômes et sans œdème
- D. Si le testicule est visible à l'examen physique
- E. Si l'échographie scrotale montre un flux sanguin altéré

C

10. Quel est le traitement de l'œdème scrotal idiopathique chez l'enfant ?

- A. Chirurgie immédiate
- B. Traitement conservateur et symptomatique (antalgique, anti-inflammatoire, antihistaminique)
- C. Appliquer de la glace directement sur la zone affectée
- D. Antibiothérapie systématique
- E. Observation pendant 3 à 5 jours

BE

Chapitre 20. VARICOCELE

1. La cause du varicocèle :

- A. Hypervascularisation dans le système veineux spermatique du testicule gauche
- B. Stase dans le système veineux spermatique du testicule gauche
- C. Hypervascularisation dans le système veineux spermatique du testicule droit
- D. Stase dans le système veineux spermatique du testicule droit
- E. Reflux sanguin dans le système veineux spermatique du testicule gauche

BE

2. Parmi les symptômes du varicocèle :

- A. Dilatation des veines spermatiques
- B. La bourse scrotale gauche est diminuée
- C. La température de la bourse scrotale gauche est augmentée
- D. La température de la bourse scrotale droite est augmentée
- E. A la palpation, un épaississement est observé lors de la manoeuvre de Valsalva

ACE

3. *Les stades d'évolution du varicocèle :

- A. Stade 1, varicocèle évidente seulement après la manoeuvre de Valsalva
- B. Stade 1, varicocèle évidente à la palpation sans manoeuvre de Valsalva
- C. Stade 2, varicocèle évidente seulement après la manoeuvre de Valsalva
- D. Stade 3, varicocèle évidente à la palpation sans manoeuvre de Valsalva
- E. Toutes les réponses sont fausses

A

4. Le traitement du varicocèle :

- A. N'est pas obligatoire à tous les stades
- B. Est obligatoire, peut importe le stade
- C. Le traitement est conservateur, non-chirurgical
- D. Le traitement consiste à la ligature de la ou les veines spermatiques
- E. Le traitement consiste en une sclérose de la veine spermatique

BDE

5. Concernant le pronostic et l'évolution du varicocèle :

- A. En post-opératoire, on peut retrouver un oedème transitoire du scrotum
- B. En post-opératoire, on peut retrouver une atrophie des glandes
- C. Le varicocèle peut persister même après une opération dans 5-10% des cas
- D. Le varicocèle peut persister même après une opération dans 15-20% des cas
- E. La récurrence est due à la méconnaissance des particularités anatomiques, telles que les veines spermatiques multiples

ABCE

Chapitre 21. TORSION OVARIENNE

1. *La définition d'une torsion ovarienne est :

- A. Torsion de l'ovaire autour de l'axe vasculaire avec interruption soudaine de l'apport sanguin
- B. Les trompes de Fallope peuvent parfois aussi se tordent
- C. Torsion entraînant une ischémie subséquente
- D. Torsion entraînant une nécrose subséquente
- E. Toutes les réponses sont vraies

E

2. La torsion ovarienne :

- A. Peut survenir en association à un kyste ovarien
- B. Peut survenir en association à une tumeur annexielle
- C. Peut survenir sur des ovaires normaux
- D. Provoque une obstruction sanguine
- E. Ne provoque pas d'obstruction sanguine

ABCD

3. Le tableau clinique d'une torsion ovarienne :

- A. Le signe cardinal de la torsion ovarienne est la fièvre
- B. Le signe cardinal de la torsion ovarienne est la douleur
- C. Parmi les symptômes on retrouve : douleur d'apparition insidieuse et légère dans le petit bassin
- D. Parmi les symptômes on retrouve : douleur d'apparition brutale et violente dans le petit bassin
- E. La douleur peut irradier vers les flancs, l'aîne ou l'abdomen

BDE

4. Les investigations paracliniques pour la torsion ovarienne :

- A. Les examens de laboratoire ne sont pas pertinents pour le diagnostic positif
- B. Les examens de laboratoire sont primordiaux pour le diagnostic positif
- C. On peut retrouver une leucocytose avec neutrophilie
- D. L'échographie abdominale est la méthode favorisée pour le diagnostic positif
- E. À l'échographie on retrouve une hypervascularisation ovarienne

ACD

5. Le traitement de la torsion ovarienne :

- A. Est une urgence chirurgicale
- B. N'est pas une urgence chirurgicale
- C. Le traitement consiste en une détorsion
- D. Le traitement consiste en une salpingectomie
- E. Le traitement consiste en une ovariopexie

ACDE

Chapitre 22. INVAGINATION INTESTINALE

1. L'invagination intestinale primaire :

- A. Est la forme la plus courante
- B. Est causée par une augmentation du péristaltisme
- C. Est causée par une diminution du péristaltisme
- D. La modification du péristaltisme peut être causée par une allergie des ganglions

mésentériques

- E. Elle est favorisée par la diversification alimentaire

ABDE

2. L'invagination intestinale secondaire

- A. Est la forme la plus courante
- B. Est causée par des tumeurs intestinales, des polypes, un diverticule de Meckel, des adhérences intestinales, un corps étranger, un dédoublement du tube digestif
- C. Est causée par un hyperpéristaltisme
- D. Est fréquent chez les bébés
- E. Est fréquent chez les enfants plus âgés

BE

3. Les mécanismes pathologiques d'une invagination intestinale, comprennent :

- A. Le prolapsus : la tête est mobile et l'anneau d'invagination est fixe
- B. Le prolapsus : la tête est fixe et l'anneau d'invagination est mobile
- C. L'inversion : l'anneau est mobile et la tête est fixe
- D. L'inversion : l'anneau est fixe et la tête est mobile
- E. Invaginations mixtes - prolapsus et inversion

ACE

4. *La symptomatologie de l'invagination intestinale comprend :

- A. La triade douleur abdominale, vomissements et saignements rectaux
- B. La triade fièvre, vomissements et saignements rectaux
- C. Uniquement des douleurs abdominales
- D. Uniquement des vomissements
- E. Aucune réponse n'est correcte

A

5. Le traitement d'une invagination intestinale :

- A. Le traitement conservateur consiste à réduire la pression hydrostatique
- B. Le traitement chirurgical consiste à réduire la pression hydrostatique
- C. Le traitement conservateur est réussi lorsque le contour du caecum est observé et que le sérum physiologique a pénétré l'iléon terminal
- D. Le traitement chirurgical consiste en une désinvagination par « écrasement » d'aval en amont avec la main entière (pas de traction)
- E. Le traitement conservateur consiste en une désinvagination par « écrasement » d'aval en amont avec la main entière (pas de traction)

ACD

Chapitre 23. ILEUS MECONIAL

1. L'iléus méconial :

- A. Est une occlusion de l'intestin grêle due à la présence de méconium anormal, visqueux et adhérent dans l'iléon proximal
- B. Est une occlusion de l'intestin grêle due à la présence de méconium anormal, visqueux et adhérent dans l'iléon terminal
- C. Représente la première manifestation de la mucoviscidose
- D. On peut observer un microcolon
- E. On peut observer un mégacolon

BCD

2. La physiopathologie de l'iléus méconial :

- A. La cause est une augmentation de la viscosité du mucus dans différentes structures de l'organisme
- B. La cause est une diminution de la viscosité du mucus dans différentes structures de l'organisme
- C. La modification de viscosité du mucus entraîne une obstruction avec ischémie, dilatation et perforation intestinale
- D. À cause de la mucoviscidose, le méconium adhère à la paroi intestinale
- E. À cause du syndrome de Hirschsprung, le méconium adhère à la paroi intestinale

ACD

3. *Les formes d'iléus méconial :

- A. Dans l'iléus méconial simple, le nouveau-né semble en bonne santé avec un méconium dans les 24-48h après l'accouchement
- B. Dans l'iléus méconial simple, on retrouve un rétrécissement abdominal, sans vomissements
- C. Dans l'iléus méconial simple, la toux rectale révèle une dilatation de l'anus et du rectum
- D. Dans l'iléus méconial compliqué, le nouveau-né semble en bonne santé à l'accouchement
- E. Dans l'iléus méconial compliqué, on ne retrouve ni perforation, ni péritonite

A

4. Les investigations paracliniques de l'iléus méconial :

- A. La radiographie abdominale montre des images de « bulles de savon » dans la fosse iliaque droite, sans niveaux hydroaériques
- B. En cas d'iléus compliqué on retrouve, à la radiographie abdominale, une ascite, une masse kystique, des calcifications péritonéales, un pneumopéritoine
- C. On fait un bilan sanguin
- D. L'irigographie montre un arrêt du produit contraste au niveau de la valvule iléo-caecale
- E. On peut faire des tests de la sueur ou encore des tests génétiques pour la mucoviscidose

ABDE

5. Le traitement de l'iléus méconial :

- A. Pour l'iléus simple, le traitement est conservateur ou chirurgical
- B. Pour l'iléus simple, le traitement consiste en une rééquilibration hydro-électrique, une décompression gastrique et une irigographie avec produit de contraste
- C. Pour l'iléus compliqué, le traitement est chirurgical si le méconium n'est pas éliminé dans les 48 premières heures
- D. Pour l'iléus compliqué, le traitement est une laparotomie avec un moulage du méconium de façon antérograde vers le colon ou rétrograde vers l'estomac
- E. Le rééquilibrage hydro-électrique n'est pas indiqué dans le méconium compliqué

BCD

Chapitre 31. ÉVALUATION DU PATIENT PÉDIATRIQUE TRAUMATISÉ

1. Quels sont les principaux facteurs qui influencent la prévention des traumatismes chez les enfants ?

- A. Le respect des règles de sécurité routière
- B. L'éducation

- C. La supervision
- D. Le statut socio-économique
- E. L'alimentation équilibrée

ABCD

2. Pourquoi les enfants sont-ils plus vulnérables aux traumatismes que les adultes ?

- A. Leur tissu conjonctif est plus élastique
- B. Leur squelette est plus malléable
- C. Leur peau est plus fine et fragile
- D. Leur capacité à réguler la température et les liquides est moindre
- E. Leur temps de récupération est plus rapide

ABD

3. Quels signes peuvent indiquer une insuffisance cardiorespiratoire imminente chez un enfant traumatisé ?

- A. Une chute brutale de la pression artérielle
- B. Des changements subtils dans la fréquence cardiaque
- C. Une modification de la perfusion des extrémités
- D. Une augmentation soudaine de la température corporelle
- E. Une absence de réaction aux stimuli

BC

4. Quelles sont les bonnes pratiques pour la prise en charge d'un enfant blessé après un accident ?

- A. Une évaluation rapide et bien organisée
- B. La prise en charge dans un environnement calme et adapté aux enfants
- C. L'isolement de l'enfant pour éviter le stress post-traumatique
- D. La présence d'un parent ou d'un tuteur dans la salle de soins
- E. L'administration immédiate d'un sédatif pour calmer l'enfant

ABD

5. Pourquoi la "heure d'or" est-elle importante en traumatologie pédiatrique ?

- A. Elle correspond à la période critique où une prise en charge rapide améliore la survie
- B. Elle permet d'assurer une meilleure prise en charge émotionnelle de l'enfant
- C. Elle définit une période clé où les soins médicaux sont les plus efficaces
- D. Elle correspond au moment où les symptômes graves commencent à apparaître
- E. Elle représente la première heure où l'enfant doit rester sous observation psychologique

AC

6. Quelles sont les principales causes de traumatisme mortel chez les enfants de moins d'un an ?

- A. Les traumatismes liés au transport
- B. L'obstruction des voies respiratoires
- C. La noyade
- D. Les chutes
- E. Les brûlures

BC

7. Quels traumatismes sont les plus fréquents chez les enfants de plus de 5 ans ?

- A. Les noyades

- B. Les traumatismes liés au transport
- C. Les accidents de la route
- D. Les morsures d'animaux
- E. Les intoxications

BC

8. Quels sont les objectifs de l'évaluation primaire lors de la prise en charge d'un enfant polytraumatisé ?

- A. Garantir des voies respiratoires dégagées
- B. Assurer une respiration adéquate
- C. Stabiliser la circulation sanguine
- D. Effectuer un examen radiologique complet immédiatement
- E. Évaluer les troubles neurologiques majeurs

ABCE

9. Quels sont les principaux éléments du protocole « ABCDE » en médecine d'urgence ?

- A. Airway (voies aériennes)
- B. Breathing (respiration)
- C. Circulation (circulation)
- D. Digestive system (système digestif)
- E. Exposure (exposition)

ABCE

10. Quels signes peuvent indiquer une insuffisance respiratoire chez un enfant polytraumatisé?

- A. Rétractions costales et respiration oscillante
- B. Cyanose malgré un apport d'oxygène
- C. Augmentation de la fréquence respiratoire avec détresse
- D. Rythme cardiaque élevé et stable
- E. Absence de bruits respiratoires

ABCE

11. Pourquoi est-il difficile d'évaluer la circulation sanguine chez un enfant polytraumatisé?

- A. Les enfants compensent bien la perte sanguine initiale
- B. La prise de pouls est plus complexe chez les enfants
- C. Les signes de décompensation cardio-circulatoire apparaissent brutalement
- D. Leur tension artérielle chute immédiatement après une hémorragie
- E. L'accès vasculaire est parfois difficile

ACE

12. Quels éléments sont évalués lors de l'examen neurologique rapide (Disability) ?

- A. Niveau de conscience
- B. Réaction aux stimuli verbaux et douloureux
- C. Réflexe photomoteur pupillaire
- D. Température corporelle
- E. État de la peau et présence d'ecchymoses

ABC

13. Pourquoi l'étape d'exposition (Exposure) est-elle essentielle dans l'évaluation d'un enfant traumatisé ?

- A. Elle permet d'identifier des blessures cachées

- B. Elle assure une recherche complète des lésions vitales
- C. Elle réduit la mortalité si elle est bien réalisée
- D. Elle est prioritaire avant l'évaluation des voies aériennes
- E. Elle nécessite de prévenir l'hypothermie

ABCE

14. Quels sont les critères influençant le transfert d'un enfant blessé vers un centre de traumatologie ?

- A. L'état du patient
- B. La gravité des blessures
- C. La disponibilité de l'ambulance
- D. La situation géographique
- E. Les politiques locales de prise en charge

ABDE

Chapitre 32. BLESSURES THORACIQUES

1. Quelles sont les caractéristiques générales du traumatisme thoracique chez l'enfant ?

- A. Il est plus fréquent chez les filles que chez les garçons
- B. Il est plus rare chez l'enfant que chez l'adulte
- C. Il est majoritairement causé par des agents non pénétrants
- D. Il est souvent associé aux accidents de la route et aux chutes
- E. Il résulte principalement de blessures par objets tranchants

BCD

2. Pourquoi les enfants sont-ils plus vulnérables aux traumatismes thoraciques ?

- A. Leur cage thoracique est plus élastique et souple
- B. Leur médiastin est plus étroit que celui des adultes
- C. Leur tête proportionnellement plus grosse prédispose à l'occlusion des voies respiratoires
- D. Leur trachée est plus longue et plus rigide
- E. Leur faible capacité résiduelle fonctionnelle peut aggraver l'hypoxémie

ACE

3. Quelles lésions thoraciques peuvent être immédiatement mortelles ?

- A. Pneumothorax sous tension
- B. Fractures des côtes
- C. Tamponnade cardiaque
- D. Hémithorax massif
- E. Contusion pulmonaire légère

ACD

4. Quelles particularités anatomiques de l'enfant influencent la prise en charge des traumatismes thoraciques ?

- A. Une trachée plus courte et plus étroite
- B. Une glotte plus postérieure et plus petite
- C. Une langue et un palais mou proportionnellement plus grands
- D. Une cage thoracique rigide avec une masse musculaire protectrice
- E. Un diamètre transversal des voies aériennes plus petit

ACE

5. Comment les traumatismes thoraciques sont-ils classifiés ?

- A. En fonction de la localisation des lésions
- B. En fonction de la gravité des blessures
- C. En blessures thoraciques, lésions pleuropulmonaires et médiastinales
- D. Selon leur cause : pénétrantes ou non pénétrantes
- E. Selon la présence ou non de fractures costales

AC

6. Quelles sont les causes principales des traumatismes thoraciques chez l'enfant ?

- A. Les accidents de la route
- B. Les chutes de hauteur
- C. Les blessures par armes blanches
- D. Les infections pulmonaires
- E. Les coups directs au thorax

ABE

7. Quelles sont les particularités anatomiques du thorax chez l'enfant ?

- A. Une cage thoracique élastique et souple
- B. Une masse musculaire protectrice importante
- C. Un médiastin plus large
- D. Une trachée plus courte et plus facile à comprimer
- E. Des côtes plus épaisses et plus résistantes aux fractures

ACD

8. Quels sont les signes cliniques possibles d'un hémithorax ?

- A. Matité à la percussion
- B. Cyanose et dyspnée
- C. Hypersonorité thoracique
- D. Oppression thoracique
- E. Déviation du médiastin vers le côté sain

ABDE

9. Quelles sont les méthodes d'imagerie utilisées pour diagnostiquer un pneumothorax ?

- A. Radiographie thoracique
- B. Scanner thoracique
- C. Échographie thoracique
- D. Angiographie
- E. IRM thoracique

ABC

10. Quelles sont les prises en charge d'un volet costal ?

- A. Contrôle de la douleur
- B. Intubation oro-trachéale si insuffisance respiratoire
- C. Ventilation en pression positive
- D. Drainage thoracique systématique
- E. Fixation chirurgicale si échec du traitement conservateur

ABCE

Chapitre 33. TRAUMATISME ABDOMINAL

1. Concernant l'épidémiologie des traumatismes abdominaux chez l'enfant, quelles affirmations sont vraies ?

- A. Ils sont la cause la plus fréquente de blessures mortelles non reconnues chez l'enfant.
- B. Ils sont plus fréquents chez les filles que chez les garçons.
- C. Les guidons de vélo sont une cause fréquente de traumatisme abdominal.
- D. La rate et le foie sont les organes les plus souvent atteints.
- E. Les traumatismes abdominaux sont généralement causés par des objets tranchants.

ACD

2. Quelles sont les particularités anatomiques et physiologiques de l'abdomen chez l'enfant ?

- A. Les organes solides sont proportionnellement plus gros que chez l'adulte.
- B. La musculature abdominale est plus développée que chez l'adulte.
- C. Les enfants ont moins de graisse sous-cutanée que les adultes.
- D. Les lésions organiques sont plus souvent causées par des mécanismes contondants.
- E. Un tiers des enfants victimes d'un traumatisme majeur ont des lésions intrapéritonéales importantes.

ACDE

3. Quels sont les signes cliniques d'un syndrome d'hémorragie interne ?

- A. Peau pâle et agitation psychomotrice
- B. Tachycardie et hypotension
- C. Présence d'un globe vésical
- D. Tympanisme percussif avec disparition de la matité hépatique
- E. Soif intense

ABE

4. Quelles sont les caractéristiques du syndrome d'irritation péritonéale ?

- A. Il est causé par la rupture des organes cavitaires.
- B. Il se manifeste par une défense musculaire ou une contracture abdominale.
- C. Il est principalement causé par une hémorragie massive des organes pleins.
- D. Il peut être confirmé par une ponction péritonéale.
- E. Il est toujours accompagné d'un globe vésical.

AB

5. Lors de l'examen clinique de l'abdomen d'un enfant traumatisé, quels éléments doivent être recherchés ?

- A. La présence d'ecchymoses et d'une marque traumatique à l'inspection

- B. La participation de l'abdomen aux mouvements respiratoires
- C. Une sensibilité importante à la palpation
- D. Une matité mobile sur les flancs pouvant indiquer un épanchement péritonéal
- E. Un globe vésical qui signe une hémorragie intrapéritonéale

ABCD

6. Concernant les examens complémentaires dans l'évaluation des traumatismes abdominaux, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'échographie FAST est un examen rapide, non invasif et utile en urgence.
- B. La tomodensitométrie (TDM) est la référence pour le diagnostic des lésions abdominales.
- C. L'échographie FAST peut être réalisée en 10 minutes en moyenne.
- D. La paracentèse est encore largement utilisée dans le diagnostic de l'hémorragie intrapéritonéale.
- E. L'échographie FAST permet d'évaluer la présence de liquide intrapéritonéal libre.

ABE

7. Concernant le traumatisme hépatique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La douleur irradie souvent vers l'épaule droite.
- B. L'échographie FAST est l'examen de choix en cas de patient hémodynamiquement stable.
- C. La TDM est la méthode d'imagerie de référence.
- D. Les transaminases sont généralement diminuées.
- E. L'hémobilie se manifeste par une triade : ictère, douleur dans l'hypochondre droit et hémorragie digestive.

ACE

8. Quels sont les critères de prise en charge conservatrice du traumatisme hépatique ?

- A. Un patient hémodynamiquement stable.
- B. Une prise en charge en réanimation avec surveillance des paramètres vitaux.
- C. Une transfusion sanguine systématique.
- D. Un traitement chirurgical immédiat.
- E. Une imagerie répétée pour surveiller l'évolution de la lésion.

ABE

9. Concernant la classification des lésions hépatiques, quelles affirmations sont justes ?

- A. Une rupture hépatique avec atteinte des vaisseaux hilaires correspond au grade.
- B. Une lacération du foie impliquant > 75 % d'un lobe correspond au grade V.
- C. Un hématome sous-capsulaire occupant 5 % de la surface hépatique est classé grade III.

- D. Une rupture intraparenchymateuse < 1 cm est classée en grade I.
- E. Un hématome sous-capsulaire occupant 40 % de la surface hépatique est de grade II.

ABDE

10. Concernant le traumatisme splénique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La rate est l'organe parenchymateux le plus souvent touché dans les traumatismes abdominaux.
- B. La prise en charge conservatrice est possible dans la majorité des cas.
- C. La laparotomie est systématique en cas de traumatisme splénique.
- D. La vaccination est recommandée après une splénectomie.
- E. Une antibiothérapie à haute dose est instaurée après une splénectomie.

ABDE

11. Quels sont les critères d'indication d'un traitement chirurgical dans un traumatisme splénique ?

- A. Instabilité hémodynamique persistante.
- B. Dévascularisation de plus de 50 % de la rate.
- C. Patient stable avec une lésion de grade I.
- D. Chute de pression artérielle < 90 mmHg avec pouls filiforme.
- E. Un volume sanguin perdu supérieur à 40 mL/kg.

ABDE

12. Concernant le traumatisme pancréatique, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Il est fréquent chez les enfants.
- B. Il est souvent associé à des lésions du duodénum.
- C. La douleur peut être en "barre".
- D. La lipase et l'amylase sont augmentées en cas de traumatisme pancréatique.
- E. Une laparotomie est systématique.

BCD

13. Quels sont les signes cliniques d'un pseudokyste pancréatique post-traumatique ?

- A. Douleurs épigastriques récurrentes.
- B. Vomissements.
- C. Diarrhée sévère.
- D. Tumeur palpable dans l'épigastre.
- E. Tachycardie persistante.

ABD

14. Concernant la prise en charge des pseudokystes pancréatiques, quelles affirmations sont exactes?

- A. Ils peuvent être absorbés spontanément.
- B. Une échographie permet de les visualiser.
- C. Une anastomose cysto-digestive est un traitement possible.
- D. Une chirurgie est systématique dès leur apparition.
- E. Un drainage externe peut être envisagé pour les formes compliquées.

ABCE

15. Concernant la perforation traumatique des organes de la cavité abdominale, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elle est le plus souvent causée par une plaie pénétrante.
- B. Elle peut être due à un écrasement de la colonne vertébrale.
- C. Elle entraîne une péritonite par contamination rapide de la cavité péritonéale.
- D. Un hématome duodénal sans perforation est une indication absolue de chirurgie.
- E. Une TDM permet d'identifier les lésions abdominales.

ABCE

16. Quels sont les signes paracliniques évocateurs d'une perforation traumatique abdominale ?

- A. Augmentation de la CRP et de la VS.
- B. Hyperbilirubinémie.
- C. Amylase sérique augmentée en cas de plaie intestinale.
- D. Radiographie abdominale révélant un pneumopéritoine.
- E. Échographie montrant un épanchement péritonéal.

ACDE

17. Concernant la prise en charge chirurgicale des perforations abdominales, quelles affirmations sont justes ?

- A. La laparotomie est systématique en cas de perforation d'un organe abdominal.
- B. Une laparotomie supra-ombilicale est indiquée pour les lésions intestinales.
- C. Une suture en double couche est recommandée pour les lésions gastriques.
- D. Une gastrojéjunostomie latéro-latérale est indiquée pour certaines lésions duodénales.
- E. Une stomie est indiquée pour des lésions intestinales anciennes ou compliquées de péritonite.

ACDE

18. Concernant les lésions du côlon, quelles sont les options thérapeutiques possibles ?

- A. Une suture à double couche.
- B. Une colostomie protectrice sus-jacente.
- C. Une hémicolectomie systématique
- D. Une iléostomie.
- E. Une prise en charge conservatrice sans chirurgie.

ABD

19. Concernant les lésions vasculaires de la racine du mésentère, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elles se manifestent par un hématome étendu entre les feuillets mésentériques.
- B. Une ligature du vaisseau lésé est toujours suffisante.
- C. Une vasorraphie peut être nécessaire en cas d'atteinte de l'axe mésentérique principal.
- D. Une ligature de l'artère mésentérique supérieure est possible chez l'enfant.
- E. Une réintervention à 48 heures permet d'évaluer la viabilité intestinale.

ACDE

20. Quel est l'objectif principal de la réintervention à 48 heures en cas de lésion vasculaire mésentérique ?

- A. Réaliser une résection intestinale étendue.
- B. Vérifier la viabilité intestinale.
- C. Assurer une nouvelle laparotomie exploratoire systématique.
- D. Éviter le syndrome de l'anse courte.
- E. Ligaturer systématiquement l'artère mésentérique supérieure.

BD

Chapitre 34. TRAUMATISME RÉNO-URINAIRE

1. Quelle est la fréquence des traumatismes rénaux parmi les traumatismes abdominaux ?

- A. Ils représentent environ 10 % des traumatismes abdominaux.
- B. Ils représentent environ 25 % des traumatismes abdominaux.
- C. Ils représentent environ 40 % des traumatismes abdominaux.
- D. Ils sont les plus fréquents après les traumatismes du foie et de la rate.
- E. Ils représentent environ 50 % des traumatismes abdominaux.

B

2. Quel est le mécanisme principal de production des traumatismes rénaux ?

- A. Contusions (80-90 %), souvent dues à des accidents de la route, des chutes de hauteur, des écrasements.

- B. Plaies pénétrantes, fréquentes chez les enfants.
- C. Traumatisme iatrogène, principalement dû à des interventions chirurgicales.
- D. Toutes les réponses sont correctes.
- E. Contusions uniquement causées par des chutes de hauteur.

A

3. Quelles sont les particularités anatomiques favorisant les traumatismes rénaux chez les enfants ?

- A. Moins de graisse péri-rénale.
- B. Des côtes plus rigides.
- C. Le rein occupe proportionnellement plus d'espace dans le rétropéritoine.
- D. Présence d'anomalies rénales de forme/position dans 1 à 5 % des cas.
- E. Le parenchyme rénal se rompt plus facilement chez les jeunes enfants avec une lobulation fœtale.

ACE

4. Quelle est la classification des traumatismes rénaux selon l'AAST (American Association for Surgery of Trauma) ?

- A. Contusion rénale (50-85 %), plaies parenchymateuses rénales incomplètes, rupture de vaisseaux segmentaires.
- B. Lésion vasculaire du pédicule rénal (2-4 %), contusion rénale, hématome sous- capsulaire.
- C. Contusion rénale, hématome sous-capsulaire, rupture des vaisseaux hilaires.
- D. Plaies parenchymateuses rénales de plus de 5 cm.
- E. Toutes les réponses sont correctes.

A

5. Quel est le signe clinique cardinal d'un traumatisme rénal ?

- A. Douleur abdominale intense.
- B. Hématurie.
- C. Masse palpable abdominale.
- D. Fièvre et frissons.
- E. Choc hémorragique.

B

6. Quelle méthode d'imagerie est la plus couramment utilisée pour évaluer les traumatismes rénaux chez les patients hémodynamiquement stables ?

- A. Radiographie abdominale.
- B. Échographie FAST
- C. Tomodensitométrie (TDM) avec produit de contraste.

- D. Angiographie.
- E. Aucun examen n'est nécessaire.

C

7. Quels examens paracliniques peuvent être utilisés pour le diagnostic d'un traumatisme rénal ?

- A. Radiographie abdominale simple.
- B. Échographie FAST.
- C. Tomodensitométrie avec produit de contraste.
- D. Tests de laboratoire montrant une anémie post-hémorragique et une hématurie.
- E. Toutes les réponses sont correctes.

E

8. Quel est le traitement de choix pour les traumatismes rénaux dans les cas de stabilité hémodynamique ?

- A. Chirurgie immédiate.
- B. Traitement conservateur avec surveillance, réanimation et perfusion de cristalloïdes.
- C. Radiothérapie.
- D. Hémodialyse.
- E. Stérilisation de l'urine.

B

9. Quels sont les signes cliniques qui peuvent accompagner un traumatisme rénal en cas de polytraumatisme ?

- A. Lombalgie.
- B. Masse palpable au niveau du flanc ou du bas du dos.
- C. Choc hémorragique (hypotension, tachycardie, altération de la conscience).
- D. Douleur thoracique.
- E. Aucune des réponses ci-dessus.

ABC

10. Quels facteurs sont pris en compte lors de l'établissement du parcours thérapeutique des traumatismes rénaux ?

- A. La gravité de la blessure.
- B. La présence de lésions d'autres organes (polytraumatisme).
- C. La stabilité hémodynamique.
- D. Tous les facteurs mentionnés ci-dessus.
- E. Aucune des réponses ci-dessus.

D

11. Quel traitement est préféré pour les blessures rénales de grade I, II et III ?

- A. Traitement conservateur, incluant rééquilibrage hydro-électrolytique, antibiothérapie et surveillance dynamique.
- B. Néphrectomie partielle.
- C. Suture des lacérations rénales.
- D. Radiothérapie.
- E. Aucun traitement n'est nécessaire.

A

12. Quelle est la durée recommandée pour le repos physique lors du traitement non opératoire des blessures rénales de grade I, II et III ?

- A. 1 à 2 semaines.
- B. 2 à 4 semaines.
- C. 4 à 6 semaines.
- D. 1 semaine maximum.
- E. Pas de période de repos recommandée.

B

13. Quand le traitement chirurgical est-il recommandé dans les traumatismes rénaux de grade III ?

- A. Dès le début, en cas de douleur intense.
- B. Lorsqu'un traitement conservateur initial échoue, en cas d'instabilité hémodynamique, ou de complications comme un infarctus rénal.
- C. Pour tous les cas de traumatismes rénaux de grade III, sans exception.
- D. Lors de la détection d'un abcès rénal.
- E. Aucun traitement chirurgical n'est nécessaire.

B

14. Quel traitement chirurgical est effectué en cas de traumatismes rénaux de grade IV et V ?

- A. Le traitement conservateur avec surveillance.
- B. Le traitement chirurgical d'urgence dès le début, incluant la néphrectomie partielle ou totale, selon la situation.
- C. Aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire.
- D. L'ablation de l'utérus en complément.
- E. La radiothérapie ciblée sur les lésions rénales.

B

15. Quelles sont les complications possibles des traumatismes rénaux ?

- A. Hémorragie rénale par rupture en deux temps d'un hématome rénal.
- B. Abscès rénal ou péri-rénal.
- C. Formation d'un uro-hématome.
- D. Hypertension rénovasculaire secondaire (1 – 3 % des cas).
- E. Toutes les réponses ci-dessus.

E

16. Concernant les perforations traumatiques des organes de la cavité abdominale, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elles peuvent être causées par une plaie pénétrante.
- B. Un cisaillement entre segments mobiles et fixes peut en être à l'origine.
- C. Elles sont le plus souvent asymptomatiques et ne nécessitent pas de prise en charge immédiate.
- D. La contamination rapide de la cavité péritonéale entraîne un tableau de péritonite.
- E. La radiographie abdominale peut révéler un pneumopéritoine.

ABDE

17. Concernant le diagnostic des perforations traumatiques des organes abdominaux, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'augmentation des marqueurs inflammatoires comme la CRP et la VS peut être observée.
- B. Une amylase sérique élevée peut suggérer une atteinte intestinale.
- C. L'échographie abdominale permet d'identifier un épanchement péritonéal.
- D. Le scanner abdominal est un examen clé pour localiser la lésion.
- E. Une simple observation clinique suffit à confirmer le diagnostic.

ABCD

18. Concernant le traitement des perforations traumatiques abdominales, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le traitement chirurgical est indiqué dans la majorité des cas.
- B. Une laparotomie supra-ombilicale est privilégiée pour un traumatisme gastrique.
- C. En cas de traumatisme intestinal, une laparotomie sous-ombilicale peut être pratiquée.
- D. La laparotomie supra-sous-ombilicale est utilisée lorsque la localisation des lésions est incertaine.
- E. Un traitement conservateur est recommandé pour toutes les perforations intestinales.

ABCD

19. Concernant les lésions gastriques traumatiques, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elles surviennent fréquemment le long de la grande courbure gastrique.
- B. Les lacérations non linéaires sont les plus courantes.
- C. Elles sont généralement traitées par simple observation et antibiothérapie.
- D. Le traitement inclut l'hémostase et le débridement des tissus dévitalisés.
- E. La suture gastrique est réalisée en deux plans.

ABDE

20. Concernant les lésions duodénales traumatiques, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les hématomes sans perforation sont traités de manière conservatrice.
- B. En cas de déchirure linéaire, une suture à double couche est réalisée.
- C. Toutes les lésions duodénales nécessitent une duodéno-pancréatectomie céphalique.
- D. Une gastro-jéjuno-anastomose peut être indiquée dans certains cas.
- E. Une ligature pylorique peut être nécessaire en cas de lésions importantes.

ABDE

21. Concernant les lésions de l'intestin grêle et du côlon, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Une suture à double couche est possible pour les lésions simples.
- B. Une résection intestinale avec anastomose termino-terminale est indiquée pour les lésions complexes.
- C. Une stomie peut être réalisée en cas de lésion ancienne ou de péritonite.
- D. Pour les lésions coliques, une iléostomie ou une colostomie protectrice peut être réalisée.
- E. Toutes les lésions intestinales peuvent être traitées sans chirurgie.

ABCD

Chapitre 35. BRÛLURES

1. Concernant la définition des brûlures, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Une brûlure est une lésion traumatique de la peau ou des muqueuses.
- B. Elle entraîne des réactions systémiques nerveuses, vasculaires, métaboliques et humorales.
- C. Elle est une lésion exclusivement locale, sans impact systémique.
- D. Elle peut être causée par des agents physiques ou chimiques.
- E. Elle peut avoir des conséquences potentiellement invalidantes et mortelles.

ABDE

2. Concernant la physiopathologie des brûlures, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La brûlure entraîne une fuite capillaire avec œdème interstitiel.
- B. Un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS) peut survenir.

- C. L'état hypermétabolique augmente le catabolisme protéique et la dépense énergétique.
- D. La régulation thermique est améliorée par l'augmentation du métabolisme.
- E. Une atteinte supérieure à 40 % de la surface corporelle peut entraîner une dépression myocardique.

ABCE

3. Concernant la classification des brûlures selon le mécanisme de production, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les brûlures thermiques peuvent être causées par des liquides chauds ou une flamme.
- B. Les brûlures électriques peuvent entraîner des lésions profondes malgré des lésions cutanées minimales.
- C. Les brûlures chimiques sont causées par des acides ou des bases.
- D. Les lésions par radiations font également partie des brûlures.
- E. Seules les brûlures thermiques entraînent des conséquences systémiques.

ABCD

4. Concernant la classification des brûlures selon la profondeur, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les brûlures du premier degré touchent uniquement l'épiderme.
- B. Les brûlures du deuxième degré peuvent être superficielles ou profondes.
- C. Les brûlures du troisième degré touchent toutes les couches de la peau.
- D. Les brûlures du quatrième degré ne concernent que la peau.
- E. Les brûlures du quatrième degré peuvent atteindre les muscles et les os.

ABCE

5. Concernant l'évaluation de la surface brûlée, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La surface brûlée est un facteur clé du pronostic.
- B. Une brûlure chez un enfant de moins de 3 ans est considérée comme plus grave.
- C. Le schéma de Wallace est utilisé pour tous les âges.
- D. Chez les enfants, le schéma de Lund et Browder est plus précis.
- E. Une surestimation de la surface brûlée de 10 à 15 % est réalisée en cas d'inhalation de fumée.

ABDE

6. Concernant la physiopathologie des brûlures, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La brûlure entraîne une réponse inflammatoire systémique avec fuite capillaire.
- B. La thermorégulation est préservée, même en cas de brûlures étendues.

- C. Une brûlure de plus de 40 % de la surface corporelle peut provoquer une dépression myocardique et une hypotension.
- D. La translocation bactérienne intestinale peut entraîner un choc septique dans les brûlures graves.
- E. L'état hypermétabolique qui suit une brûlure entraîne une augmentation de la masse musculaire

ACD

7. Concernant la classification et le traitement des brûlures, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Les brûlures de grade II.B (partielle profonde) peuvent nécessiter une greffe de peau.
- B. Les brûlures de grade I nécessitent systématiquement une hospitalisation et un traitement antibiotique.
- C. Les brûlures de grade III nécessitent une intervention chirurgicale pour leur fermeture.
- D. Les brûlures de grade IV atteignent les muscles et les os et nécessitent une prise en charge complexe.
- E. Les brûlures superficielles nécessitent toujours un traitement par greffe de peau.

ACD

8. Concernant les brûlures, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Les brûlures superficielles (grade I) n'affectent que l'épiderme.
- B. Les brûlures de grade II.A touchent le derme profond et nécessitent toujours une greffe de peau.
- C. Les brûlures de grade III atteignent toutes les couches de la peau, y compris l'hypoderme.
- D. Les brûlures de grade IV peuvent s'étendre jusqu'aux muscles et aux os.
- E. Toutes les brûlures de grade II guérissent en moins d'une semaine.

ACD

9. Quels éléments sont exacts concernant la durée de guérison des brûlures ?

- A. Une brûlure de grade I guérit en 2 à 5 jours.
- B. Une brûlure de grade II.B peut nécessiter jusqu'à 5 semaines pour cicatriser.
- C. Une brûlure de grade III guérit spontanément en moins de trois semaines.
- D. Une brûlure de grade IV ne guérit pas spontanément.
- E. Une brûlure de grade II.A nécessite une hospitalisation systématique.

ABD

10. Concernant la prise en charge des brûlures, quelles affirmations sont correctes ?

- A. Les brûlures de grade II.A nécessitent un pansement stérile et l'application d'une pommade antimicrobienne.
- B. Une brûlure de grade III peut être prise en charge par un traitement conservateur ou une greffe de peau.
- C. Les brûlures de grade IV nécessitent toujours une hospitalisation en soins intensifs
- D. Une réhydratation orale est suffisante pour toutes les brûlures, quel que soit le grade.
- E. Une brûlure de grade I peut être traitée par une simple application d'eau à température ambiante et des antalgiques légers.

ABCE

Chapitre 36. FRACTURES, ENTORSES, LUXATIONS SPÉCIFIQUES AUX ENFANTS

1. Quelles sont les caractéristiques du squelette de l'enfant par rapport à celui de l'adulte ?

- A. L'os de l'enfant est plus poreux et plus élastique que celui de l'adulte.
- B. Le périoste de l'enfant est plus fin et se déchire facilement.
- C. Le potentiel de remodelage osseux de l'enfant est plus important.
- D. Le cartilage de croissance est une zone faible prédisposant à des fractures particulières.
- E. Un enfant plus jeune mettra plus de temps à guérir d'une fracture qu'un adolescent.

ACD

2. Quelles affirmations sont vraies concernant les fractures obstétricales ?

- A. La fracture de la clavicule est la plus fréquente des fractures obstétricales.
- B. Les fractures obstétricales touchent souvent l'humérus et le fémur.
- C. La fracture de l'humérus peut être associée à une paralysie du plexus brachial.
- D. La fracture de la clavicule obstétricale nécessite toujours un traitement chirurgical.
- E. La fracture obstétricale du fémur est souvent confondue avec une luxation coxofémorale.

ABCE

3. Parmi les fractures spécifiques aux enfants, lesquelles sont correctement décrites ?

- A. La fracture en "bois de vert" est une fracture incomplète où un seul côté de l'os est brisé.
- B. La déformation plastique entraîne une rupture complète de l'os.
- C. La fracture sous-périostée est complète mais les fragments restent maintenus par le périoste.
- D. La fracture par compression touche la zone métaphysaire des os longs.
- E. Les fractures sous-périostées et par compression sont identiques.

ACD

4. Selon la classification de Salter-Harris, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le type I correspond à une luxation simple de l'épiphyse.
- B. Le type II est la fracture la plus fréquente et affecte la métaphyse.
- C. Le type III touche uniquement la métaphyse.
- D. Le type IV traverse l'épiphyse et la métaphyse.
- E. Le type V entraîne une destruction irréversible du cartilage de croissance.

ABDE

5. À propos des fractures supracondyliennes, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Elles surviennent généralement après une chute sur le membre supérieur en extension.
- B. Elles sont plus fréquentes chez les adolescents que chez les enfants de 5 à 7 ans.
- C. Les fractures de type extension représentent plus de 95 % des cas.
- D. Le traitement peut être orthopédique ou chirurgical selon le type de fracture.
- E. La classification de Gartland permet d'évaluer la gravité de la fracture.

ACDE

Chapitre 38. DYSPLASIE DU DEVELOPPEMENT DE LA HANCHE

1. Quelle est la principale caractéristique de la dysplasie coxofémorale ?

- A. Une relation anormale entre la tête fémorale et l'acétabulum
- B. La luxation complète de la hanche dès la naissance
- C. Une pathologie uniquement présente chez les nouveau-nés prématurés
- D. La subluxation partielle de la tête fémorale
- E. Une malformation de la hanche due à des anomalies de la moelle épinière

AD

2. Parmi les facteurs suivants, lesquels sont responsables de la dysplasie coxofémorale ?

- A. Une position intra-utérine anormale
- B. Une mauvaise alimentation maternelle
- C. Des antécédents familiaux de dysplasie coxofémorale
- D. La prise de médicaments par la mère pendant la grossesse
- E. L'hyperlaxité capsulo-ligamentaire

ACE

3. Quelle est la signification de la luxation tératologique de la hanche ?

- A. Elle résulte d'une malformation congénitale
- B. Elle est liée à des syndromes neuromusculaires tels que la paralysie cérébrale
- C. Elle peut être corrigée par des manœuvres orthopédiques
- D. Elle est plus fréquente chez les filles
- E. Elle se distingue de la dysplasie coxofémorale par son embryogenèse différente

BE

4. Quels tests cliniques sont utilisés pour évaluer la dysplasie coxofémorale chez le nourrisson ?

- A. Le test de Trendelenburg
- B. La manœuvre de Barlow
- C. La manœuvre d'Ortolani
- D. La radiographie du bassin
- E. Le test de Pavlik

BC

5. Quels signes cliniques peuvent être observés chez un nourrisson présentant une luxation de la hanche ?

- A. Asymétrie des plis fessiers
- B. Mouvements du membre supérieur limités
- C. Pli inguinal plus bas sur un côté
- D. Mouvements anormaux du cou
- E. Gait de type « canard » ou de Trendelenburg chez les enfants plus grands

ACE

6. À quel âge recommande-t-on de réaliser une échographie de la hanche pour les nouveau-nés à risque ?

- A. À la naissance
- B. À 2 semaines
- C. À 6 semaines
- D. À 4-6 semaines
- E. À 4 mois

D

7. Quels sont les facteurs de risque les plus courants pour la dysplasie coxofémorale ?

- A. Naissance par césarienne
- B. Antécédents familiaux de dysplasie coxofémorale
- C. Position du nourrisson en siège lors de l'accouchement
- D. Sexe masculin
- E. Oligoamnios

BCE

8. Quelle est l'importance de l'échographie dans le diagnostic de la dysplasie coxofémorale ?

- A. Elle permet d'évaluer les os fémoraux
- B. Elle donne une image précise de la relation entre la tête fémorale et l'acétabulum
- C. Elle est utilisée seulement chez les enfants de plus de 6 mois
- D. Elle permet de visualiser les ligaments et cartilages de la hanche
- E. Elle n'est pas recommandée avant 6 mois

BD

9. Quel est le principal traitement de la dysplasie coxofémorale chez les nouveau-nés et jeunes nourrissons ?

- A. La rééducation motrice
- B. Le port d'un harnais Pavlik
- C. La chirurgie dès les premiers mois
- D. L'immobilisation complète du membre

- E. La prise de médicaments antispasmodiques

B

10. Quelles complications peuvent résulter d'une dysplasie coxofémorale non traitée ?

- A. Douleurs chroniques
- B. Arthrose précoce
- C. Déformation du pied
- D. Scoliose
- E. Handicap locomoteur sévère

ABDE

Chapitre 39. MALADIE DE LEGG-CALVÉ-PERTHES

1. Quel est le principal facteur épidémiologique de la maladie de Legg-Calvé- Perthes ?

- A. L'âge inférieur à 3 ans
- B. Le sexe féminin
- C. La classe socio-économique supérieure
- D. L'âge entre 3 et 12 ans
- E. La race asiatique

D

2. Parmi les théories étiopathogéniques de la maladie de Legg-Calvé-Perthes, laquelle est la plus controversée ?

- A. La théorie vasculaire
- B. La théorie inflammatoire
- C. La théorie traumatique
- D. La théorie génétique
- E. Aucune de ces réponses

ABC

3. Quelles sont les manifestations cliniques initiales de la maladie de Legg-Calvé- Perthes ?

- A. Douleur au genou
- B. Douleur à la hanche
- C. Boiterie indolore
- D. Perte de rotation interne
- E. Fébrilité

BCD

4. Quel est le principal signe radiologique précoce de la maladie de Legg-Calvé- Perthes ?

- A. Élargissement de l'espace articulaire médial
- B. Sclérose de la tête fémorale
- C. Apparition du signe du croissant
- D. Fracture du col fémoral
- E. Déplacement de la tête fémorale

AB

5. Quel est l'objectif principal du traitement de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?

- A. Maintenir la tête fémorale dans l'acétabulum
- B. Assurer une bonne mobilité de la hanche
- C. Réduire la douleur immédiatement
- D. Résorber la nécrose rapidement
- E. Prévenir les fractures

AB

6. Quel est le principal critère utilisé dans la classification de Catterall ?

- A. La déformation de la tête fémorale
- B. L'étendue de la lésion épiphysaire
- C. La douleur ressentie par l'enfant
- D. La présence de boiterie
- E. L'âge de l'enfant

B

7. Quel est le principal traitement conservateur recommandé pour les enfants atteints de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?

- A. Limitation de l'activité physique
- B. Repos au lit pendant plusieurs mois
- C. Rééducation intense
- D. Port de corset ou d'orthèses
- E. Médicaments anticoagulants

AD

8. Quelles sont les complications possibles de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?

- A. Coxa plana
- B. Ostéochondrite disséquante
- C. Inégalité de la longueur des membres
- D. Arthrite septique
- E. Fractures du col fémoral

ABC

9. Quelle est le pronostic favorable de la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?

L'âge inférieur à 6 ans

Le sexe masculin

L'obésité

Une tête fémorale bien formée

La survenue d'une subluxation latérale

AD

10. Quelle est la durée approximative de la période de guérison pour la maladie de Legg-Calvé-Perthes ?

- A. 1 à 2 ans
- B. 2 à 5 ans
- C. 5 à 10 ans
- D. Moins de 6 mois

E. Plus de 10 ans

B

Chapitre 50. LE MEGAURETERE CONGENITAL

1. À propos de la sténose de la jonction urétéro-vésicale :

- A. La sténose de la jonction urétéro-vésicale est la cause la plus fréquente d'hydronéphrose congénitale
- B. Elle est plus fréquente chez les garçons
- C. Le diagnostic prénatal repose le plus souvent sur la cystographie
- D. L'échographie postnatale montre un uretère dilaté de plus de 7 mm
- E. La scintigraphie rénale permet d'évaluer la sévérité de l'obstruction

BDE

2. Concernant le reflux vésico-urétéral (RVU) :

- A. Est toujours bilatéral
- B. Favorise les infections urinaires récidivantes
- C. Peut être secondaire à une duplication urétérale
- D. Ne nécessite jamais de traitement chirurgical
- E. Est toujours associé à une dilatation de l'uretère à l'échographie

BC

3. Quel(s) diagnostic(s) différentiel(s) devez-vous évoquer devant un mégaurètre obstructif ?

- A. Reflux vésico-urétéral
- B. Urétérocèle
- C. Valve urétrale postérieure
- D. Uretère ectopique
- E. Hypospadias

ABCD

Chapitre 51. LE SYSTEME DOUBLE COLLECTEUR

1. Le système double collecteur :

- A. Est toujours bilatéral
- B. Est une anomalie acquise
- C. Peut être asymptomatique
- D. Est plus fréquent chez la fille que chez le garçon
- E. Est détecté uniquement après la naissance

CD

2. Selon la loi de Weigert-Meyer, dans une duplication complète :

- A. L'uretère du pôle supérieur s'ouvre plus caudalement
- B. L'uretère du pôle inférieur s'ouvre plus crânialement
- C. Les deux uretères s'unissent toujours avant d'entrer dans la vessie
- D. Chaque système collecteur possède son propre uretère
- E. L'ouverture de l'uretère du pôle supérieur est latérale et basse

BD

3. Dans le cadre d'un système double collecteur, on peut dire que :

- A. L'échographie postnatale est inutile en cas d'asymptotomie
- B. La cystographie est utile pour évaluer un reflux associé
- C. Le traitement est toujours chirurgical
- D. La scintigraphie au DMSA permet d'évaluer le parenchyme rénal
- E. L'IRM est systématique chez tous les patients

BD

Chapitre 52. L'URETEROCELE

1. Concernant l'urétérocèle, cochez les affirmations exactes :

- A. Elle correspond à une dilatation kystique de l'uretère au niveau du segment distal intravésical
- B. Elle est secondaire à une infection urinaire chronique
- C. Elle est souvent associée à un système double collecteur
- D. L'orifice urétéral est généralement large et perméable
- E. Elle peut entraîner une dilatation des voies urinaires sus-jacentes

ACE

2. Quels examens permettent de poser ou de compléter le diagnostic d'urétérocèle ?

- A. Échographie postnatale
- B. Cystographie
- C. Scintigraphie osseuse
- D. Uro-IRM
- E. Uro-TDM

ABDE

3. Le traitement de l'urétérocèle peut inclure :

- A. Une antibiothérapie prophylactique
- B. Une néphrectomie systématique
- C. Une fenestration endoscopique
- D. Une réimplantation urétérale en cas d'échec de traitement initial
- E. L'abstention thérapeutique dans tous les cas

ACD

Chapitre 53. EXTROPHIE VÉSICALE

1. À propos de l'extrophie vésicale, quelles affirmations sont exactes ?

- A. C'est une malformation congénitale rare touchant davantage les filles
- B. L'extrophie est due à un défaut de formation de la membrane cloacale antérieure
- C. L'urètre présente un mur antérieur intact
- D. L'ombilic est inséré au pôle supérieur de la plaque vésicale
- E. Le diastasis pubien est une caractéristique fréquente

BDE

2. Quel(s) examen(s) ou constat(s) permet(tent) le diagnostic d'une extrophie vésicale ?

- A. Échographie prénatale dès 10 semaines
- B. IRM fœtale pour évaluer les détails anatomiques
- C. Diagnostic évident à la naissance
- D. Recherche systématique de malformations associées
- E. Test de Guthrie

BCD

3. Concernant le traitement de l'extrophie vésicale, cochez les propositions exactes :

- A. Il doit être réalisé idéalement dans les premières 72 heures de vie
- B. Une intervention unique est suffisante chez les garçons
- C. La reconstruction de la symphyse pubienne fait partie du geste chirurgical
- D. La correction de l'épispadias est réalisée avant toute autre intervention
- E. L'incontinence urinaire peut persister malgré le traitement

ACE

Chapitre 54. VALVES CONGENITALES DE L'URETRE POSTERIEUR

1. Les valves congénitales de l'urètre postérieur :

- A. Touchent les deux sexes de manière égale
- B. Sont la cause la plus fréquente d'obstruction sous-vésicale chez le garçon
- C. Résultent d'un défaut de résorption de la membrane cloacale postérieure
- D. Sont classées en trois types selon Young
- E. Sont dues à une anomalie d'insertion du canal de Wolff dans la cloaque

BDE

2. À propos des manifestations cliniques et examens d'imagerie :

- A. L'échographie fœtale peut montrer le "keyhole sign"
- B. Une hydronéphrose bilatérale doit faire évoquer une valve urétrale postérieure
- C. La cystographie mictionnelle est l'examen de référence postnatal
- D. Le diagnostic est souvent posé par scintigraphie rénale
- E. L'insuffisance respiratoire néonatale peut être liée à une hypoplasie pulmonaire secondaire à l'oligoamnios

ABCE

3. Concernant la prise en charge et le pronostic :

- A. L'ablation endoscopique est le traitement de référence
- B. Une sonde ou une cystostomie peut être utilisée en première intention si l'endoscopie est impossible
- C. Le pronostic est toujours favorable à long terme
- D. Le shunt vésico-amniotique est indiqué pour toutes les formes prénatales
- E. Une insuffisance rénale chronique peut survenir dans les formes sévères

ABE

Chapitre 55. HYPOSPADIAS. EPISPADIAS

1. Cochez les affirmations exactes à propos de l'hypospadias :

- A. L'ouverture urétrale est située sur la face postérieure du pénis
- B. Il est souvent associé à un prépuce incomplet
- C. Le diagnostic est évident à la naissance
- D. Les formes périnéales peuvent être confondues avec un trouble du développement sexuel
- E. Le traitement chirurgical est idéalement réalisé après la puberté

BCD

2. L'hypospadias est associé à quelles anomalies anatomiques ?

- A. Un méat urétral situé à l'extrémité du gland
- B. Une corde fibreuse responsable d'une courbure du pénis
- C. Une fermeture circulaire normale du prépuce
- D. Une sténose fréquente du méat urétral
- E. Une duplication de l'urètre

BD

3. Concernant l'épispadias, cochez les affirmations correctes :

- A. L'ouverture urétrale se situe sur la face dorsale du pénis
- B. Il est plus fréquent que l'hypospadias
- C. Il peut être associé à l'extrophie vésicale
- D. Il existe des formes balaniques, pénienues et complètes
- E. Il ne nécessite aucun traitement

ACD

Chapitre 56. PHIMOSIS. PARAPHIMOSIS

1. Cochez les affirmations exactes concernant le phimosis :

- A. Il est toujours pathologique, quel que soit l'âge
- B. Il peut être congénital ou acquis
- C. Le phimosis physiologique persiste généralement au-delà de 5 ans
- D. L'examen clinique suffit pour poser le diagnostic
- E. Il gêne souvent la miction chez le jeune enfant

BD

2. Le traitement du phimosis peut inclure :

- A. Circoncision systématique chez tous les enfants avant 3 ans
- B. Rétractions douces et hygiène locale avant 5 ans
- C. Phimotomie dorsale dans les formes simples
- D. Circoncision dans les phimosis cicatriciels
- E. Abstention thérapeutique dans tous les cas

BCD

3. Le paraphimosis :

- A. Est une urgence chirurgicale immédiate dans tous les cas
- B. Est toujours asymptomatique
- C. Peut entraîner une ischémie du gland
- D. Nécessite une réduction manuelle en première intention
- E. Résulte d'une rétraction du prépuce qui ne peut plus être repositionné

CDE